

KC桌面——外资精译

GS：月度与季度数据变化观察

MRNA 报价表现优于板块和大盘（年初至今 vs. XBI +61%；vs. 标普500 +76%），主要受益于：1）市场对今年与默克合作开发的个体化新抗原疗法 intismeran 在辅助性黑色素瘤中的三期中期数据持乐观态度，这是一个二元事件，可能确立商业肿瘤学业务线，并根据正在进行的九项二期和三期研究，为向其他实体瘤的积极解读带来扩张机会；以及

2）读者对近期收入前景的信心增强，该前景已基本企稳，注意到 2026 财年指引为同比收入增长高达 10%（GS/一致预期为 7.2%/7.8%），这包含了美国新冠疫苗接种量可能下降的因素——我们关注的上行空间包括 mNEXSPIKE 市场份额同比提升和疫苗接种率，鉴于季节性因素，这些动态的可见性将在夏季/初秋显现。我们认为，在上述两个因素的背景下，空头头寸已回落至 52 周低点——但绝对值仍然较高。在当前水平（每股 54 美元），前述黑色素瘤研究的成功在很大程度上已被定价——然而，期权市场暗示，若成功，到 1 月中旬报价将上涨 49%；在不利情景下，报价将回归基础业务（约每股 25 美元）——请参阅我们对此数据的深入分析。

对于第二季度业绩，MRNA 已给出总收入指引为 5000 万至 1 亿美元（GS/FactSet 一致预期为 9000 万/1.03 亿美元），美国和国际地区各占一半。我们对处方数据的分析表明，MRNA 能够达到指引，但需注意总收入的一部分为非产品收入，因此我们对其可见性较低。我们预测 GAAP 每股收益为 2.11 美元，而一致预期为 2.03 美元。我们预计电话会议将围绕以下问题展开：1）黑色素瘤三期数据的时间安排、披露策略和统计考量，2）从黑色素瘤到其他实体瘤适应症解读（我们预计接下来将在今年/2027 年初获得肾细胞癌的二期数据，随后是肌层浸润性膀胱癌，非小细胞肺癌数据可能在 2027 年获得），3）近期科学日披露的管线资产，以及 4）季节性流感方面的收入前景，鉴于该疫苗的 PDUFA 日期为 8 月 5 日（我们预计将获批），这可能为 2027 年及以后的美国收入做出贡献。

我们预计第二季度 GAAP 每股收益将符合预期。对于第二季度业绩，我们预计总收入为 9000 万美元（FactSet 一致预期为 1.03 亿美元），主要由 Spikevax/mNEXSPIKE/mRESVIA 产品收入 5800 万美元和其他收入 3200 万美元（包括制造收入和合作收入）驱动。MRNA 给出的第二季度收入指引为 5000 万至 1 亿美元。我们预测 GAAP 每股收益为 2.11 美元，而一致预期为 2.03 美元。

图表 1：GS 预测 vs. 一致预期

关键催化剂：在肿瘤学业务线（我们认为这是 MRNA 报价的关键驱动因素）中，我们预计到 2027 年上半年将有多个催化剂。特别是对于与默克合作的个体化新抗原疫苗 intismeran，我们预计：1）2026 年下半年将公布与 Keytruda 联用的辅助性黑色素瘤三期中期数据，这是读者关注的核心，2）今年或 2027 年初将公布辅助性肾细胞癌（RCC）的二期数据，随后是 2027 年的肌层浸润性膀胱癌数据，以及 3）2027 年将公布非小细胞肺癌（NSCLC）的三期数据（NSCLC 的下一更新将围绕完成试验入组展开，这将为提供时间预期）。在 intismeran 之外但仍在肿瘤学领域，我们预计：1）今年将公布针对多发性骨髓瘤的 T 细胞衔接器 mRNA-2808 的 1/2 期初步数据，MRNA 认为其通过靶向三个抗原（BCMA、GPC5D 和 FcRH5）有可能与传统双特异性方法区分开来——我们承认这在竞争激烈/拥挤的治疗格局中很重要，2）2027 年将公布癌症抗原疗法 mRNA-4359（靶向 PD-L1 和 IDO1）的额外 1/2 期数据，3）2026 年下半年将公布针对包括多发性硬化症在内的 Epstein-Barr 病毒相关疾病的治疗方法的 1 期数据，2028 年将公布 2 期概念验证数据，以及 4）2027 年及以后将公布针对晚期实体瘤的其他癌症抗原疗法的数据。我们还注意到季节性流感单药疗法的 PDUFA 日期为 8 月 5 日（我们基本预计将获批），这可能为 2027 年及以后的美国总收入做出贡献，以及今年将公布的诺如病毒三期数据和罕见病丙酸血症的注册数据，这两者都不是市场关注的焦点。

图表 2：直至 2027 年的关键催化剂

估值与不确定性

MRNA（中性）：我们对 MRNA 更新公司观点。， 基于 100% DCF 估值（终端增长率 4%，加权平均资本成本 11%）。上行不确定性：商业不确定性——销售额和患者群体渗透率高于预期，INT 项目获批时间早于预期，其他管线成功以及竞争对手失败。节奏变化不确定性：未能证明在其他模式（如潜伏病毒疫苗）或其他肿瘤适应症中的临床概念验证，知识产权不确定性，制造困难以及融资/稀释，未能实现预期的商业前景，医生/支付方对使用和覆盖的抵制，竞争对手药物获批。

资料来源：公司数据、GS预测、FactSet。价格截至 2026 年 7 月 24 日收盘。

披露附录：公司情况更新

Reg AC

我们，Salveen Richter,CFA、Elizabeth Webster,Ph.D.、Mark Aleynick,Ph.D.、Matt Dellatorre,Ph.D.、Tommie Reerink,CFA、Lydia Erdman 和 Shrunatra Mishra，特此证明本报告中表达的所有观点准确反映了我们个人对相关公司或公司及其标的的看法。我们还证明，我们的薪酬中没有任何部分直接或间接与本报告中表达的具体建议或观点相关。

撰稿人：Salveen Richter,CFA、Elizabeth Webster,Ph.D.、Mark Aleynick,Ph.D.、Matt Dellatorre,Ph.D.、Tommie Reerink,CFA、Lydia Erdman、Shrunatra Mishra。

GS因子概况

GS因子概况通过将公司的关键属性与市场（即我们的评级公司范围）及其行业同行进行比较，提供研究背景。所描绘的四个关键属性是：增长、财务回报、倍数（例如估值）和综合（增长、财务回报和倍数的组合）。增长、财务回报和倍数是通过使用每只公司特定指标的标准化排名来计算的。然后将这些指标的标准化排名进行平均，并转换为相关属性的百分位数。每个指标的具体计算可能因财年、行业和地区而异，但标准方法如下

增长基于公司的前瞻性销售增长、EBITDA增长和EPS增长（对于资金股，仅考虑EPS和销售增长），百分位数越高表明公司增长越快。财务回报基于公司的前瞻性ROE、ROCE和CROCI（对于资金股，仅考虑ROE），百分位数越高表明公司财务回报越高。估值倍数基于公司的前瞻性市盈率（P/E）、市净率（P/B）、股息率（P/D）、企业价值/EBITDA（EV/EBITDA）、企业价值/自由现金流（EV/FCF）和企业价值/债务调整后现金流（EV/DACF）（对于资金股，仅考虑P/E、P/B和P/D），百分位数越高表明公司交易倍数越高。综合百分位数计算为增长百分位数、财务回报百分位数和（100%-估值倍数百分位数）的平均值。

财务回报和估值倍数使用GS分析师对未来至少三个季度后的财年末预测。增长使用对未来至少七个季度后的财年预测，与至少三个季度后的财年进行比较（所有指标均基于每股数据）。

有关我们如何计算GS因子组合的详细说明，请联系您的GS代表。

并购排名：公司情况更新

在我们全球覆盖范围内，我们使用并购框架审视公司，综合考虑定性因素和定量因素（可能因行业和地区而异），以纳入某些公司可能被收购的潜力。然后我们分配并购排名，作为对我们评级覆盖范围内的公司进行评分的方法，从1到3，其中1表示公司成为收购目标的可能性高（30%-50%），2表示可能性中等（15%-30%），3表示可能性低（0%-15%）。对于排名为1或2的公司，根据我们部门的标准指引。并购排名为3被视为不重要，并且可能在研究报告中讨论或不讨论。

Quantum

Quantum是GS专有数据库，可提供详细的财务报表历史、预测和比率。它可用于对单一公司进行深入分析，或比较不同行业和市场公司。